BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH AFB TRỰC TIẾP NHUỘM ZIEHL-NEELSEN

Mã hiệu: **VS.NS.06.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Trọng Hiếu**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
3	Mục đích	Bỏ "thực hiện kiểm tra thuốc nhuộm"
4	Kiểm tra chất lượng	Bổ sung Kiểm tra mẫu bệnh phẩm trước khi nhuộm
6	Diễn giải kết quả và báo cáo	Bỏ "Thao tác sử dụng kính hiển vi"

1. MỤC ĐÍCH

- Mô tả các bước kỹ thuật làm tiêu bản AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này áp dụng tại khoa Vi sinh bệnh viện Đa Khoa Đức Giang

3. TRÁCH NHIỆM

- Xét nghiệm viên được phân công làm xét nghiệm nhuộm soi.
- Nhóm trưởng chịu trách nhiệm giám sát.
- Nhân viên chất lượng có trách nhiệm kiểm soát quy trình.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- ***Định nghĩa:*** Xét nghiệm đờm trực tiếp tìm trực khuẩn lao là biện pháp quan trọng nhất, là cách chẩn đoán chắc chắn nhất lao phổi.
- Xét nghiệm đờm có thể dùng phương pháp nhuộm Ziehl-Neelsen hoặc phương pháp huỳnh quang dùng ánh sáng cực tím.
- AFB: Acid Fast Bacillus.
- CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
- XN: Xét nghiệm.
- LQAS: Phương pháp kiểm định theo lô.

5. NGUYÊN LÝ

- *Mycobacteria* có lớp vách dày nên khó bắt mày với thuốc nhuộm thông thường và có tính kháng cồn, kháng acid. Phương pháp nhuộm Ziehl do thuốc nhuộm có chứa phenol và hơ nóng khi nhuộm nên Fuchsin ngấm qua lớp vách vi khuẩn khi tẩy mày bằng dung dịch cồn-acid, AFB vẫn giữ được màu đỏ Fuchsin trong khi các tế bào và vi khuẩn khác bị tẩy màu đỏ; khi nhuộm nền tạo sự tương phản giữ AFB màu đỏ trên nền xanh.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT SINH PHẨM, BỆNH PHẨM

a. Vật tư trang thiết bị:

- Tủ ATSH cấp 2 được kiểm chuẩn hàng năm
- Bồn nhuộm tiêu bản
- Kính hiển vi
- Lam kính có đầu nhám, bút chì
- Khay inox sạch
- Hộp đựng tiêu bản
- Vòi nước
- Que tre
- Đèn cồn
- Khay đựng tiêu bản

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Thùng rác thải y tế, thùng kháng thủng

b. Hóa chất sinh phẩm:

- Bộ nhuộm Ziehl-neelsen
- Dầu soi
- Dung dịch sát khuẩn

c. Bệnh phẩm:

- Bệnh phẩm đờm: có nhày mủ, thích tích mẫu ít nhất 2ml
- Cặn bệnh phẩm sau ly tâm

7. CẢNH BÁO AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động mang găng tay.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm.
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.
- Đảm bảo luồng khí lưu thông trong tủ ATSH không bị ảnh hưởng bởi các vật liệu che lấp. Kết thúc công việc, lau tủ bằng cồn 70°.
- Khử nhiễm vật liệu lây nhiễm sau khi kết thúc công việc.

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Kiểm tra chất lượng thuốc nhuộm theo tuần hoặc trước khi sử dụng lô mới theo "Quy trình nội kiểm thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen", mã tài liệu VS.NS.15.
- Nhuộm chứng dương và chứng âm cùng mẻ nhuộm tiêu bản thông thường. Đọc kết quả chứng dương và chứng âm trước khi đọc tiêu bản của bệnh nhân, ghi chép vào "Sổ nội kiểm tiêu bản hàng ngày", mã tài liệu BM.01.VS.NS.06:

+ Chuẩn bị sẵn lô tiêu bản từ mẫu đờm biết trước kết quả âm tính và dương tính ở mức độ 1+, theo "Hướng dẫn sản xuất tiêu bản nội kiểm nhuộm Ziehl-Neelsen", mã tài liệu HD.01.VS.NS.06 và ghi chép lại vào biểu mẫu BM.02.VS.NS.06

+ Kết quả thuốc nhuộm "Đạt" chất lượng: tiêu bản dương thấy AFB bắt màu đỏ trên nền xanh sáng, không thấy cặn thuốc nhuộm, tiêu bản âm không thấy AFB

+ Kết quả thuốc nhuộm "Không đạt" chất lượng: tiêu bản dương không thấy AFB hoặc AFB nhạt màu, nền xanh tối, thấy cặn thuốc nhuộm hoặc tiêu bản âm thấy AFB

+ Nếu kiểm tra không đạt, tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ và thực hiện lại quy trình, ghi chép vào "Phiếu báo cáo sự không phù hợp", mã tài liệu: BM.01.XN.QL.02 và lập "Phiếu yêu cầu-báo cáo hành động khắc phục", mã tài liệu: BM.02.XN.QL.03 nếu cần. Nếu vẫn không đạt phải hủy bỏ toàn bộ thuốc nhuộm

- Ghi thời gian mở bộ thuốc nhuộm lên vỏ lọ và ký tên người mở. Bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo và tránh ánh nắng mặt trời.
- Kiểm tra mẫu bệnh phẩm trước khi nhuộm: không thực hiện mẫu bệnh phẩm lẫn nước bọt.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

9. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

9.1 Chuẩn bị

- Ghi số xét nghiệm của bệnh nhân trên nắp và trên thân cốc đựng bệnh phẩm, thống nhất từ phiếu xét nghiệm, cốc đờm và lam kính.
- Số xét nghiệm gồm 2 phần tử: tử số là số thứ tự trong sổ xét nghiệm, mẫu số là số thứ tự của mẫu bệnh phẩm (ví dụ: 187/1, 187/2). Số xét nghiệm theo thứ tự liên tục từ đầu năm đến cuối năm của sổ xét nghiệm theo CTCLQG.
- Cập nhật thông tin bệnh nhân vào "Sổ xét nghiệm AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen" theo "Hướng dẫn cập nhật thông tin bệnh nhân xét nghiệm AFB", mã tài liệu HD.02.VS.NS.06 trước khi thực hiện kỹ thuật
- Chọn lam kính mới, sạch, không vỡ, không xước, mốc. Hơ lam kính trên ngọn lửa đèn cồn để loại bỏ mỡ và nấm mốc.
- Ghi số xét nghiệm vào đầu nhám của lam kính, ghi bằng bút chì. Không chạm tay vào phần mặt trên còn lại của lam kính.
- Khởi động tủ ATSH trước khi sử dụng ít nhất 15 phút để tủ chạy ổn định.
- Sắp xếp dụng cụ, vật liệu cần thiết vào tủ ATSH: que tre làm tiêu bản, bô can chứa chất sát khuẩn, khay sạch đựng tiêu bản, lam kính, cốc đựng bệnh phẩm đờm.

9.2 Dàn tiêu bản

- Mở nhẹ nắp cốc đờm nhẹ nhàng, cẩn thận tránh tạo hạt khí dung. Đặt nắp ngửa trên khay
- Quan sát kỹ mẫu đờm, dùng đầu vát của que tre phết đờm, chọn mảnh đờm nhày mủ, nhẹ nhàng cắt mẫu đờm bằng cách di cạnh vát que tre vào thành cốc đờm. Đậy nắp cốc đờm
- Đặt mẫu đờm lên giữa lam kính trùng số với cốc đờm, mặt vát que tre dàn đờm trên lam kính theo hình bầu dục kích thước 1x2cm, quay mũi nhọn que tre dàn tiếp tạo độ mịn cho vết dàn. Dàn đờm đều đặn, liên tục theo hình xoắn ốc từ trung tâm ra ngoài hoặc theo kiểu tóc rối, dàn đến khi thấy đờm hơi se. Không dàn khi đờm đã khô
- Bỏ que dàn bệnh phẩm đã dùng vào bô can chứa dung dịch sát khuẩn
- Mỗi 1 bệnh phẩm của 1 bệnh nhân phải dùng que riêng biệt
- Để tiêu bản khô tự nhiên 15-30 phút hoặc trên máy làm khô

Chú ý: Không làm khô trên ngọn lửa đèn cồn

9.3 Cố định tiêu bản

- Xếp tiêu bản theo thứ tự lên giá nhuộm sao cho mặt tiêu bản quay lên trên
- Các tiêu bản cách nhau ít nhất 1cm, mỗi lần không nhuộm quá 7 tiêu bản

9.4 Nhuộm tiêu bản

9.4.1 Nhuộm màu

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Phủ dung dịch Fuchsin kín toàn bộ bề mặt tiêu bản
- Hơ nóng tiêu bản đã nhỏ Fuchsin carbol từ phía dưới đến khi bốc hơi
- Nếu Fuchsin tràn ra ngoài, bổ sung thêm và hơ nóng lại
- Rửa tiêu bản dưới vòi nước chảy nhẹ cho trôi hết thuốc nhuộm
- Nghiêng tiêu bản cho ráo nước

Chú ý: không để Fuchsin bị sôi

9.4.2 Tẩy màu

- Ngâm tiêu bản trong dung dịch cồn-acid trong bồn ngâm, sao cho đầu nhám quay lên trên, để trong 3 phút
- Rửa nhẹ nhàng tiêu bản dưới vòi nước
- Nghiêng lam kính cho nước chảy hết
- Sau khi rửa, các tiêu bản không còn màu hồng (nếu còn màu hồng thì tẩy lại lần nữa, thời gian 1-3 phút cho đến khi hết màu hồng, rửa lại với nước)

9.4.3 Nhuộm nền

- Phủ đầy bề mặt tiêu bản với dung dịch xanh methylene
- Để trong 30 giây – 1 phút
- Rửa nước, nghiêng lam kính cho ráo nước

Chú ý: cho vòi nước chảy nhẹ nhàng từ đầu tiêu bản. KHÔNG xối vòi nước thẳng vào vết dàn tiêu bản để tránh bong, trôi tiêu bản và tránh nhiễm chéo

9.5 Làm khô tiêu bản

- Xếp tiêu bản lên giá, để khô tự nhiên hoặc làm khô bằng máy làm khô tiêu bản

Chú ý: không làm khô tiêu bản bằng cách hơ tiêu bản qua ngọn lửa hay dùng khăn hoặc giấy để thấm khô

10. DIỄN DẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

10.1 Cách soi tiêu bản và nhận định kết quả

- Soi tiêu bản trên vật kính x100 (vật kính dầu) theo quy trình "Hướng dẫn sử dụng kính hiển vi", mã tài liệu VS.HD.05.01.
- **Cách soi:** soi đường giữa từ trái qua phải (tương đương 100 vi trường)

+ Điều chỉnh ốc vi cấp cho hình ảnh rõ nét nhất, quan sát kỹ từ ngoại vi vào trung tâm vi trường để phát hiện AFB

+ Đọc xong vi trường thứ nhất, chuyển sang đọc các vi trường kế tiếp cho đến hết dòng. Khi cần đọc >100 vi trường, chuyển sang dòng kế tiếp từ trái sang phải

+ Đọc ít nhất 100 vi trường trước khi kết luận là tiêu bản có kết quả âm tính (chú ý: có thể đọc ít hơn 100 vi trường nếu tiêu bản có kết quả dương tính cao với AFB, hoặc đọc nhiều hơn trong trường hợp âm tính)

- **Nhận định kết quả:** Hình ảnh AFB từ bệnh phẩm có hình que mảnh, hơi cong, bắt

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

màu đỏ, đứng riêng biệt hay xếp thành từng cụm, dễ nhận biết trên nền xanh. Đếm số lượng AFB và ghi kết quả theo quy định (Bảng hướng dẫn đọc kết quả nhuộm soi AFB)

- Kết quả được ghi lại vào "Sổ xét nghiệm trực tiếp AFB"', mã tài liệu BM.01.VS.NS.06. Cập nhật thông tin lên cổng thông tin của CTCLQG: vitimes.org

Bảng hướng dẫn đọc kết quả nhuộm soi AFB

Số lượng AFB	Kết quả	Định lượng
Không AFB/ít nhất 100 vi trường	Âm tính	Âm tính
1-9 AFB/100 vi trường	Dương tính	Ghi số lượng cụ thể
10-99 AFB/100 vi trường	Dương tính	1+
1-10 AFB/1vi trường (soi ít nhất 50 vi trường)	Dương tính	2+
>10 AFB/1 vi trường (soi ít nhất 20 vi trường)	Dương tính	3+

10.2 Lưu trữ tiêu bản

- Không ghi kết quả soi trên tiêu bản.
- Các tiêu bản sau khi soi xong, làm sạch dầu soi bằng cách xếp tiêu bản vào hộp bảo quản có lót giấy mềm để thấm dầu soi chảy xuống.
- Xếp các tiêu bản vào hộp đựng tiêu bản theo thứ tự trong "Sổ xét nghiệm AFB trực tiếp" của CTCLQG để phục vụ cho công tác kiểm định tiêu bản.
- Hộp tiêu bản lưu ở nơi thoáng, khô ráo và tránh ảnh nắng trực tiếp.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Các sai sót hay gặp:

+ Mẫu đờm cố định không tốt sẽ bị bong trôi trong quá trình nhuộm, rửa nước

+ Tẩy màu Fuchsin không hết dẫn đến nhận định nhầm hình ảnh cặn thuốc nhuộm hay mảnh thức ăn lẫn trong bệnh phẩm là AFB

- Các thao tác sai hay làm:

+ Dàn tiêu bản quá dày hoặc quá mỏng, cố định tiêu bản không tốt, nhuộm Fuchsin không đủ thời gian dẫn đến kết quả sai, thiếu

+ Đọc tiêu bản không có hệ thống, không theo đúng thứ tự sẽ dẫn đến bỏ sót (không đủ 100 vi trường)

- Kết quả dương tính trong sổ xét nghiệm phải được ghi bằng mực đỏ

12. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ xét nghiệm AFB trực tiếp	Sử dụng biểu mẫu của CTCLQG	Hồ sơ xét nghiệm AFB nhuộm Ziehl-Neelsen	5 năm
Sổ nội kiểm tiêu bản hàng ngày	BM.01.VS.NS.06	Hồ sơ xét nghiệm AFB nhuộm Ziehl-Neelsen	5 năm
Phiếu sản xuất tiêu bản nội kiểm nhộm Ziehl-Neelsen	BM.02.VS.NS.06	Hồ sơ xét nghiệm AFB nhuộm Ziehl-Neelsen	5 năm
Hướng dẫn sản xuất tiêu bản nội kiểm nhuộm Ziehl-Neelsen	HD.01.VS.NS.06	Phòng làm việc	
Hướng dẫn cập nhật thông tin bệnh nhân xét nghiệm AFB	HD.02.VS.NS.06	Phòng làm việc	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Sổ tay khách hàng	STDVKH.XN
Quy trình nhuộm Ziehl-Neelsen	VS.NS.15

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

SỔ NỘI KIỂM TIÊU BẢN HÀNG NGÀY

Mã tiêu bản		Số lô	Hạn sử dụng
Chứng dương			
Chứng âm			

Kiểm tra tiêu bản dương tính 1+	Đạt	Không đạt
Tiêu bản 1		
Kiểm tra tiêu bản Âm tính		
Tiêu bản 1		

Hà Nội, ngày…..tháng …. Năm 201...

Người xem xét **KTV thực hiện**

Mã tiêu bản		Số lô	Hạn sử dụng
Chứng dương			
Chứng âm			

Kiểm tra tiêu bản dương tính 1+	Đạt	Không đạt
Tiêu bản 1		
Kiểm tra tiêu bản Âm tính		
Tiêu bản 1		

Hà Nội, ngày…. tháng …. Năm 201…..

Người xem xét **KTV thực hiện**

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

PHIẾU SẢN XUẤT TIÊU BẢN NỘI KIỂM ZIEHL-NEELSEN

SẢN XUẤT TIÊU BẢN CHỨNG DƯƠNG

Ngày sản xuất	Họ tên BN	Tuổi	Số xét nghiệm	Kết quả

Mã số tiêu bản	Số lượng	Số lô	Hạn sử dụng

SẢN XUẤT TIÊU BẢN CHỨNG ÂM

Ngày sản xuất	Họ tên BN	Tuổi	Số xét nghiệm	Kết quả

Mã số tiêu bản	Số lượng	Số lô	Hạn sử dụng

Hà Nội, ngày…tháng ….năm …..

Người xem xét **KTV thực hiện**

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT TIÊU BẢN NỘI KIỂM NHUỘM ZIEHL-NEELSEN

1. Sản xuất tiêu bản chứng dương

- Tiêu bản chứng dương được sản xuất từ bệnh phẩm dương tính ở mức độ 1+, 2+, 3+ của bệnh nhân lao phổi AFB dương tính, thông thường để thực hiện nội kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm trực tiếp người ta dùng bệnh phẩm dương tính ở mức độ 1+
- Tiêu bản được làm chứng dương phải được ghi rõ nguồn gốc bệnh phẩm được lấy từ bệnh nhân nào (ghi rõ họ và tên bệnh nhân, tuổi, số xét nghiệm và mức độ dương tính trong sổ xanh chương trình)
- Bệnh phẩm được hòa loãng với nước muối sinh lý đã được hấp tiệt trùng theo tỷ lệ 1:1. Mục đích của bước hòa loãng là để bệnh phẩm được đồng nhất khi phết lam cho kết quả tương đồng nhau
- Để kiểm tra lại sự đồng nhất kết quả trong mỗi lần sản xuất, lấy ngẫu nhiên 3-5 tiêu bản đem nhuộm và soi để đánh giá kết quả và khẳng định sự đồng nhất của các tiêu bản chứng dương được sản xuất
- Đánh mã số tiêu bản (tùy thuộc vào người làm tiêu bản mẫu). Thông thường mã số tiêu bản được kí hiệu bằng cả chữ cái và chứ số

VD: A01, A02…

- Thực hiện phết lam theo đúng quy trình kĩ thuật và lưu vào hộp lam nội kiểm
- Ghi chép vào sổ sản xuất lam nội kiểm số lượng tiêu bản chứng được sản xuất, số lô và hạn sử dụng

2. Sản xuất tiêu bản chứng âm

- Tiêu bản được làm chứng âm phải được ghi rõ nguồn gốc bệnh phẩm được lấy từ bệnh nhân nào (ghi rõ họ và tên bệnh nhân, tuổi, số xét nghiệm trong sổ chương trình)

3. Cập nhật kết quả nội kiểm vào sổ nội kiểm hàng ngày

- Thực hiện nội kiểm xét nghiệm trực tiếp hàng ngày bằng cách nhuộm 01 tiêu bản chứng dương và 01 tiêu bản chứng âm, kết quả ghi vào sổ nội kiểm. Trưởng hộp nội kiểm đạt sẽ tiến hành thực hiên xét nghiệm cho các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân trong ngày hôm đó. Trong trường hợp nội kiểm không đạt thì cần phải kiểm tra toàn bộ các bước thực hiện kỹ thuật và thực hiện hành động khắc phục, đồng thời ghi chép vào Phiếu báo cáo sự không phù hợp, mã tài liệu BM.02.VS.QL.13

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN BỆNH NHÂN XÉT NGHIỆM AFB

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH AFB TRỰC TIẾP NHUỘM ZIEHL-NEELSEN

Họ tên người được đánh giá: .....

Ngày đánh giá: .....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Khởi động tủ ATSH 15 phút trước khi sử dụng		
2	Điền thông tin bệnh nhân, số xét nghiệm bệnh nhân vào Sổ xét nghiệm AFB trực tiếp		
3	Ghi số xét nghiệm của bệnh nhân lên phần nhám của lam kính bằng bút chì		
4	Dùng que tăm tre cắt vát, cắt lấy mảnh đờm nhày, dàn đều lên lam kính. Để khô tự nhiên hoặc cố định trên máy sấy lam		
5	Phủ Fucshin lên vị trí dàn bệnh phẩm, hơ nóng bằng ngọn lửa đèn cồn đến khi bốc hơi. Rửa dưới vòi nước chảy nhẹ		
6	Tẩy màu bằng Cồn-Acid đến khi hết màu đỏ. Rửa dưới vòi nước chảy nhẹ		
7	Phủ xanh methylene lên vị trí dàn bệnh phẩm trong 30 giây - 1 phút. Rửa dưới vòi nước chảy nhẹ		
8	Để khô tự nhiên hoặc làm khô bằng máy sấy lam		
9	Soi trên vật kính x100, đánh giá kết quả		
10	Ghi kết quả vào Sổ xét nghiệm AFB trực tiếp. Nhập thông tin kết quả của bệnh nhân lên hệ thống cổng thông tin theo đường dẫn: vitimes.org.vn		
Tổng điểm			